

Protokół jednej *sesji* (OST)

Trzygodzinna intensywna ekspozycja z terapeutą — 85–90% remisji w prostych fobiach. Lars-Göran Öst (1989).

CZAS: 2,5–3 h sesji głównej 1 sesja przygotowawcza + 1 główna + 1 kontrolna (ang. *follow-up*)

ŹRÓDŁO: Öst (1989); Davis, Ollendick & Öst (2019)

JAK UŻYWAĆ

Trzy spotkania. **Sesja 1** (50 min): wywiad, psychoedukacja, wspólna hierarchia. **Sesja 2** (do 3 h): pełna ekspozycja in vivo — terapeuta najpierw *modeluje* (sam dotyka pająka, podchodzi do psa), potem stopniowo przekazuje kontakt pacjentowi. Eksperymenty behawioralne sprawdzają katastroficzne oczekiwania. **Sesja 3** (po 1–2 tyg.): podsumowanie, plan na przyszłość.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Öst i wsp. (2001, meta-analiza): skuteczność 85–90%, NNT≈2 — najlepszy stosunek czasu do efektu w psychoterapii. Davis i wsp. (2012): efekt utrzymuje się do 4 lat. **Dlaczego jedna sesja działa:** mózg potrzebuje *naruszenia oczekiwania* (ang. *expectancy violation*) — jedno, ale głębokie i wielokrotne. Trzygodzinna sesja daje to, czego 10 sesji po 50 min nie potrafi. **NICE CG159 (2013)** rekomenduje OST jako leczenie pierwszego wyboru u dorosłych i dzieci.

PRZED Mój ogólny lęk wobec obiektu fobii — teraz, przed sesją.

Lęk
bazowy

brak lęku (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

paniczny
lęk

01 ☉ Dla kogo protokół jednej sesji

✓ IDEALNIE PASUJE

Jeden konkretny obiekt fobii: **pająk, pies, wąż, wysokość, latanie, dentysta, zastrzyk**. Wysoka motywacja. Brak ciężkich chorób współistniejących. Preferencja krótkiego leczenia.

✗ WYMAGA INNEGO PLANU

Liczne fobie naraz · ciężka depresja lub PTSD (zespół stresu pourazowego) · aktualne ryzyko samobójcze · uzależnienie od substancji · obiekt fobii niedostępny realnie (wtedy: VR lub wyobrażeniowa).

02 🕒 Struktura sesji głównej (do 3 godzin)



Kluczowa zasada: terapeuta jest *przy Tobie* przez cały czas, ale *nie robi za Ciebie*. Modeluje, wspiera, zadaje pytania sokratejskie („co się właśnie stało? czy katastrofa nadeszła?”). To Ty wchodzisz w kontakt z bodźcem — z każdą minutą bardziej samodzielnie.

03 Czego się spodziewać podczas sesji

PIERWSZA GODZINA

SUDS często rośnie do 80–100. Pojawia się myśl: „nie dam rady, muszę wyjść”. To **normalne** — mózg robi ostatnią próbę uniknięcia. Terapeuta to przewiduje i pomaga przeczekać.

DRUGA GODZINA

Lęk zaczyna spadać. Pierwsze chwile **spokojnego kontaktu** z obiektem — często ze zdziwieniem („to ten pająk? takie małe coś?”). Mózg zapisuje nowe skojarzenie.

TRZECIA GODZINA

„Przeuczenie” (ang. *overlearning*) — robisz to, co już *idzie*, w różnych kontekstach. Im więcej powtórzeń, tym trwalsza zmiana.

PO SESJI

Wyczerpanie (emocjonalne, nie fizyczne). Często ulga i lekka euforia. Czasem wątpliwość: „czy to zostanie?”. Tu wchodzi praca domowa — utrzymanie kontaktu z bodźcem 2–3×/tydz.

04 Plan utrzymania — 4 tygodnie po sesji

Sukces sesji nie wystarczy — mózg potrzebuje **powtarzanej praktyki** w różnych kontekstach, żeby nowe uczenie się utrwaliło. Wpisz konkretne plany ekspozycji w domu.

TYDZIEŃ	PLAN EKSPOZYCJI kontekst, czas, częstotliwość	ZREALIZOWANE	ŚREDNI SUDS
		tak / nie	0–100
Tydz. 1			
Tydz. 2			
Tydz. 3			
Tydz. 4			

Klucz: Skuteczność 85–90% po jednej trzygodzinnej sesji (Öst, 2001) — to najlepszy wskaźnik w całej psychoterapii. Davis i wsp. (2012): efekt utrzymuje się minimum 4 lata. Warunki: *dostępność realnego obiektu*, motywacja, brak współistniejących ciężkich zaburzeń.